ПРИКАЗЫ И ПИСЬМА В ИЗЛОЖЕНИИ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

Холера

Подозрение на холеру на выезде: эпидемиологический анамнез, клиника дегидратации, противоэпидемический режим и маршрутизация

Источник: информационные письма ГБУЗ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы № 1-14/771 от 16.03.2023, № 1-14/600 от 20.02.2024 и № 1-14/2454 от 08.08.2024.
Серия «Крещение поворотом» · версия 1.1 · 11 октября 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

О чём письма

По холере Станция выпускает информационные письма серийно — по мере ухудшения эпидемиологической ситуации в мире. Действующее письмо № 1-14/2454 от 08.08.2024 издано по письму Управления Роспотребнадзора по Москве от 06.08.2024 «О дополнительных мерах, направленных на минимизацию рисков осложнения эпидситуации по холере»; более ранние письма № 1-14/771 (2023) и № 1-14/600 (февраль 2024) содержат ту же схему действий с обновлением статистики. Поскольку операционная часть у писем общая, в этом материале они изложены вместе.

Для бригады правило одно и короткое: **у любого пациента с рвотой и диареей собирается эпидемиологический анамнез — выезды за пределы страны и по России; при подозрении на холеру действует приказ Станции № 2710 от 10.11.2023 о мероприятиях по санитарной охране территории.**

Холера как болезнь

Холера — острая кишечная инфекция, вызываемая токсигенными вибрионами *Vibrio cholerae* серогрупп O1 и O139. Механизм передачи фекально-оральный: вода, пища, контактно-бытовой путь. Инкубационный период от нескольких часов до 5 суток — именно этот срок определяет глубину эпидемиологического анамнеза. Болезнь относится к карантинным (конвенционным) инфекциям: подозрение на неё включает противоэпидемический режим ещё до лабораторного подтверждения.

Клиническая картина определяется потерей жидкости:

Признак	Характеристика
Диарея	Обильная водянистая, без боли в животе; стул в виде «рисового отвара», объём испражнений может достигать нескольких литров в сутки
Рвота	Профузная, без предшествующей тошноты, присоединяется после диареи
Дегидратация	Развивается за часы: сухость слизистых и кожи, снижение тургора, осиплость голоса, афония, судороги икроножных мышц, цианоз, «рука прачки»
Гемодинамика	Тахикардия, падение артериального давления, шок при дегидратации III–IV степени
Температура	Обычно нормальная или пониженная — отличие от большинства кишечных инфекций

Отсутствие лихорадки и боли в животе при обильной водянистой диарее — признак, отграничивающий холеру от типичной острой кишечной инфекции; при их наличии подозрение снижается, но не снимается.

Стул в виде «рисового отвара» — мутноватая беловато-серая жидкость без запаха кала с хлопьями слизи, напоминающая воду, в которой варился рис (рис. 1). Его вид объясняется механизмом диареи: холерный токсин активирует аденилатциклазу энтероцитов и вызывает массивную секрецию воды и электролитов в просвет кишки без воспаления слизистой, поэтому в стуле нет крови и почти нет каловых масс.



Рис. 1. Стул пациента с холерой: мутная беловатая жидкость без каловой окраски — «рисовый отвар». Фото: Ajay Kumar Chaurasiya, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

«Рука прачки» — морщинистая, сухая, холодная кожа пальцев и кистей со сниженным тургором, напоминающая кожу рук после длительного пребывания в воде (рис. 2). Признак отражает потерю внеклеточной жидкости и соответствует тяжёлой дегидратации (III–IV степени).



Рис. 2. Взрослый пациент с тяжёлой дегидратацией при холере: запавшие глаза, заострившиеся черты лица, морщинистая кожа кисти со сниженным тургором — «рука прачки». Фото: CDC, Wikimedia Commons, общественное достояние.

Эпидемиологическая ситуация по письмам

По последнему письму, с начала 2024 года в мире зарегистрировано более 142 тысяч случаев холеры и 218 тысяч подозрительных случаев в 32 странах с более чем 2,5 тысячами летальных исходов; наибольшее число случаев — Афганистан, Сомали, Замбия, Зимбабве, Мозамбик, Индия. Письмо № 1-14/600 фиксировало 856 тысяч случаев за 2023

год в 38 странах и завозы в Европу, США и Мексику; в России в 2023 году зарегистрированы два завозных случая из Индии. Письмо № 1-14/771 (2023) сообщало о выделении культур *V. cholerae* O1 в ряде регионов России, включая объекты водной среды.

По Москве на момент последнего письма: прирост острых кишечных инфекций к аналогичному периоду +6,6 %, отдельно отмечены ротавирусная (+20,9 %) и норовирусная (+13,5 %) инфекции — то есть фоновая заболеваемость ОКИ растёт на фоне риска завоза.

Что предписано бригаде и диспетчерской

Кому	Предписание
Единая городская диспетчерская	При оформлении вызова к пациенту с ОКИ (рвота, диарея) уточнять у вызывающего выезд за рубеж и вносить сведения в приложение к вызову
Выездной персонал	Тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у пациентов, прибывших из эпидемически неблагополучных по холере стран
Заведующие и старшие врачи	При выявлении пациента с подозрением на холеру обеспечить соблюдение приказа № 2710 от 10.11.2023 (противоэпидемический режим и санитарная охрана территории); довести письмо до персонала

Действия при подозрении

Подозрение формируется сочетанием: профузная водянистая диарея и рвота с быстрой дегидратацией **плюс** выезд в неблагополучный регион в пределах инкубационного периода (до 5 суток).



Рис. 3. Порядок действий при подозрении на холеру по письмам № 1-14/771, № 1-14/600 и № 1-14/2454: от эпиданамнеза к противоэпидемическому режиму приказа № 2710.

Противоэпидемический режим по приказу № 2710 включает работу в средствах индивидуальной защиты, мероприятия по дезинфекции, изоляцию пациента и

госпитализацию в стационар инфекционного профиля с уведомлением старшего врача смены. Помощь по состоянию ведётся по Алгоритмам при острой кишечной инфекции и дегидратации: оральная регидратация при сохранном питье, инфузионная терапия при выраженной дегидратации и шоке.

Письма касаются только противоэпидемической части и лечения не описывают. Помощь при дегидратации оказывается по Алгоритмам ДЗМ: раздел «Острые кишечные инфекции» (A02–A05, A08, A09) отсылает к разделу «Дегидратация, уменьшение объёма жидкости, гиповолемический шок» (E86, R57.1), который предписывает полиионный сбалансированный раствор 500–1000 мл внутривенно со скоростью 10 мл/кг/ч, при сохранении систолического давления ниже 80 мм рт. ст. — второй венозный доступ и норэпинефрин.

> **Расхождение РФ ↔ международная практика.** Расхождение касается не режима, а объёма и скорости регидратации. По плану С ВОЗ при тяжёлой дегидратации, характерной для холеры, внутривенно вводится раствор Рингера с лактатом 100 мл/кг: у пациентов старше года — 30 мл/кг за первые 30 минут и 70 мл/кг за последующие 2,5 часа, у детей до года — 30 мл/кг за первый час и 70 мл/кг за 5 часов. Стартовая скорость у взрослого, таким образом, составляет около 60 мл/кг/ч, что в шесть раз превышает скорость, предписанную Алгоритмами (10 мл/кг/ч). Потери жидкости со стулом при тяжёлой холере у взрослого достигают 1 л/ч (Harris et al., *Lancet*, 2012), и инфузия в режиме раздела E86 возмещает их лишь частично; это значение имеет при длительной транспортировке и при шоке. Антибиотик (доксициклин у взрослых, азитромицин у детей и беременных) по рекомендациям ВОЗ и CDC сокращает длительность диареи и назначается в стационаре.

Предписания писем

- ЕГДЦ уточняет выезд за рубеж при оформлении вызовов с рвотой и диареей и вносит сведения в приложение к вызову.
- Выездной персонал собирает эпидемиологический анамнез у прибывших из неблагополучных стран.
- При подозрении на холеру — неукоснительное соблюдение приказа № 2710 от 10.11.2023.
- Письма доводятся до сведения персонала подразделений.

Источники

- Информационные письма ГБУЗ «ССиНМП им. А. С. Пучкова» ДЗМ № 1-14/771 от 16.03.2023, № 1-14/600 от 20.02.2024, № 1-14/2454 от 08.08.2024.
- Приказ ССиНМП им. А. С. Пучкова № 2710 от 10.11.2023 «Об обеспечении мероприятий по предупреждению заноса и распространения инфекционных (паразитарных) болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории города Москвы».
- Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи. Приказ ДЗМ г. Москвы № 535 от 18.05.2023 — разделы «Острые кишечные инфекции» (A02–A05, A08, A09) и «Дегидратация, уменьшение объёма жидкости, гиповолемический шок» (E86, R57.1).
- World Health Organization. The treatment of diarrhoea: a manual for physicians and other senior health workers. 4th rev. Geneva: WHO, 2005 — план С регидратации при тяжёлой дегидратации.

- Harris J.B., LaRocque R.C., Qadri F. et al. Cholera. *Lancet*, 2012; 379(9835): 2466–2476.
- WHO. Cholera — Global outbreak response guidance; CDC. Cholera — Vibrio cholerae infection: clinical management.

Источники иллюстраций

Файл	Что изображено	Источник
`images/risovyy_otvar.jpg`	Стул пациента с холерой («рисовый отвар»)	Wikimedia Commons, «Cholera patient rice water stool.jpg», автор Ajay Kumar Chaurasiya, CC BY-SA 4.0
`images/ruka_prachki.jpg`	Пациент с тяжёлой дегидратацией, «рука прачки»	Wikimedia Commons, «Adult cholera patient.jpg», CDC, общественное достояние
`images/podozrenie_na_holeru.png`	Порядок действий бригады при подозрении на холеру	Построена для проекта по письмам (`images/postroit.py`)

Выходные данные

Холера · версия 1.1 · октябрь 2026 · Серия «Крещение поворотом» · CC BY-NC-SA 4.0. Материал носит справочный характер и не заменяет действующие приказы и клинические рекомендации.

Нашли ошибку — напишите в «Обсуждениях» репозитория на GitHub.